

Notfallmedikamente

19 Medikamente aus Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin mit Dosierung, Wirkung, Nebenwirkungen, Kontraindikationen und Pflegehinweisen.



Bestehen ist planbar.

Anästhesie

Intensivmedizin

Notfallmedizin

Pflegehinweise

19

Medikamente

3

Fachbereiche

A4

druckfertig

INHALT

1

Anästhesie (7 Medikamente)

2

Intensivmedizin (6 Medikamente)

3

Notfallmedizin (6 Medikamente)

△ Nur zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken. Ersetzt keine Fachinformation, keinen Klinikstandard und keine ärztliche Anordnung. Dosierungen immer gegen die aktuellen Standards deiner Einrichtung prüfen.

Anästhesie

7 Medikamente

Propofol Hypnotikum

DOSIS	1-2,5 mg/kg i.v. Einleitung; 4-12 mg/kg/h TIVA
WIRKUNG	Bewusstseinsverlust, Sedierung, leichte Analgesie, antiemetisch
NEBENWIRKUNGEN	Blutdruckabfall, Atemdepression, Injektionsschmerz, Lipidinfusion
KONTRAINDIKATIONEN	Sojaallergie, Eiweißallergie, Propofol-Infusions-Syndrom bei >48h
PFLEGE & PRAXIS	Blutdruck überwachen, Apnoe-Bereitschaft, nicht >48h auf ICU, Emulsion kühl lagern

Remifentanyl Opioid (ultrakurz)

DOSIS	0,05-2 µg/kg/min i.v. (TIVA)
WIRKUNG	Starke Analgesie, Atemdepression, Bradykardie, Hustendämpfung
NEBENWIRKUNGEN	Atemdepression, Bradykardie, Rigidität (hohe Dosen), Hyperalgesie nach Absetzen
KONTRAINDIKATIONEN	Relative KI: Spontanatmung ohne Monitoring
PFLEGE & PRAXIS	NUR unter Beatmung! Sofort antagonisieren mit Naloxon bei Überdosierung, nie als Bolus

Fentanyl Opioid

DOSIS	1-3 µg/kg i.v.; Pflaster 12-200 µg/h
WIRKUNG	Starke Analgesie, Sedierung, Hustendämpfung
NEBENWIRKUNGEN	Atemdepression, Übelkeit, Obstipation, Suchtpotenzial
KONTRAINDIKATIONEN	MAO-Hemmer (Kombination!), schwere Ateminsuffizienz
PFLEGE & PRAXIS	Naloxon bereithalten, Atemfrequenz überwachen, Pflaster: Hautreaktion prüfen

Midazolam Benzodiazepin

DOSIS	0,03-0,3 mg/kg/h i.v. Sedierung; 1-2,5 mg Anxiolyse
WIRKUNG	Anxiolyse, Sedierung, Amnesie, Muskelrelaxation, antikonvulsiv
NEBENWIRKUNGEN	Atemdepression, Blutdruckabfall, paradoxe Reaktionen (Kinder/Ältere), Abhängigkeit
KONTRAINDIKATIONEN	Myasthenia gravis, schwere Leberinsuffizienz
PFLEGE & PRAXIS	Antagonist: Flumazenil! Atemüberwachung, bei Agitation paradoxe Reaktion bedenken

Rocuronium Nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans

DOSIS	0,6 mg/kg Intubation; 0,1-0,2 mg/kg Erhalt
WIRKUNG	Neuromuskuläre Blockade → Muskellähmung, Intubationsbedingungen
NEBENWIRKUNGEN	Anaphylaxie möglich · Relaxansüberhang (Restblockade) · wirkt weder sedierend noch analgetisch
KONTRAINDIKATIONEN	Myasthenia gravis (relativ)
PFLEGE & PRAXIS	Immer mit Hypnotikum und Analgetikum kombinieren – sonst ist der Patient gelähmt, aber wach! Relaxometrie, Antagonist: Sugammadex

Succinylcholin Depolarisierendes Muskelrelaxans

DOSIS	1-1,5 mg/kg i.v. RSI
WIRKUNG	Schnelle vollständige Muskelrelaxation (60s), kurze Wirkdauer 10-15 Min.
NEBENWIRKUNGEN	Faszikulationen, Hyperkaliämie, Bradykardie, MH-Trigger!, Histaminfreisetzung
KONTRAINDIKATIONEN	Verbrennungen, Querschnitt, MH-Disposition, Hyperkaliämie, Pseudocholinesterasemangel
PFLEGE & PRAXIS	MH-Notfallset bereit! Dantrolen griffbereit! Nur RSI-Indikation

Ketamin (S-Ketamin) Dissoziatives Anästhetikum

DOSIS	1-2 mg/kg i.v. Anästhesie; 0,1-0,5 mg/kg Analgesie
WIRKUNG	Dissoziation, Analgesie, Bronchodilatation, Kreislaufstimulation, erhält Schutzreflexe
NEBENWIRKUNGEN	Halluzinationen, Alpträume, Tachykardie, RR-Anstieg, Hypersalivation
KONTRAINDIKATIONEN	Hypertensive Krise, erhöhter Hirndruck (relativ), Psychosen
PFLEGE & PRAXIS	Kombination mit Midazolam (Halluzinationen!), Licht dimmen, ruhige Umgebung, Absaugbereitschaft (Hypersalivation)

Intensivmedizin

6 Medikamente

Noradrenalin Vasopressor (α_1 -Agonist)

DOSIS	0,01-1,0 $\mu\text{g/kg/min}$ i.v. Perfusor
WIRKUNG	Vasokonstriktion $\rightarrow$ MAP $\uparrow$, wenig Herzfrequenzeffekt
NEBENWIRKUNGEN	Periphere Ischämie, Tachykardie, Hypertonie bei Überdosierung
KONTRAINDIKATIONEN	Hypovolämie ohne Volumenersatz (relativ)
PFLEGE & PRAXIS	Nur ZVK oder sichere Kanüle! Backup-Perfusor! NIE unterbrechen! 4-Augen-Prinzip bei Zubereitung

Adrenalin Katecholamin ($\alpha+\beta$ -Agonist)

DOSIS	0,01-1 $\mu\text{g/kg/min}$ Perfusor; 1mg i.v. Reanimation
WIRKUNG	Herzfrequenz $\uparrow$, Kontraktilität $\uparrow$, Vasokonstriktion, Bronchodilatation
NEBENWIRKUNGEN	Tachykardie, Arrhythmien, Hypertonie, Myokardischämie
KONTRAINDIKATIONEN	Relative KI: schwere KHK, Tachyarrhythmien
PFLEGE & PRAXIS	Bei Anaphylaxie: 0,5mg i.m.! Bei Reanimation: 1mg i.v. alle 3-5 Min.

Dobutamin Positiv-inotrop (β_1 -Agonist)

DOSIS	2-20 $\mu\text{g/kg/min}$ i.v. Perfusor
WIRKUNG	Herzfrequenz $\uparrow$, Kontraktilität $\uparrow$ (inotrop), Vasodilatation (β_2)
NEBENWIRKUNGEN	Tachykardie, Arrhythmien, RR-Abfall möglich
KONTRAINDIKATIONEN	Obstruktive Kardiomyopathie, schwere Aortenklappenstenose
PFLEGE & PRAXIS	Häufig kombiniert mit Noradrenalin, HF-Monitoring, EKG

Heparin (unfraktioniert) Antikoagulans

DOSIS	Initial 5000 IE i.v.; Erhalt nach aPTT (Ziel 60-80s)
WIRKUNG	Hemmung der Gerinnungskaskade (IIa, Xa), schnell wirksam, kurze HWZ
NEBENWIRKUNGEN	Blutungen, HIT (Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II!), Hyperkaliämie
KONTRAINDIKATIONEN	Aktive Blutung, HIT Vorgeschichte, schwere Thrombozytopenie
PFLEGE & PRAXIS	Thrombozyten täglich! HIT-Verdacht: Heparin sofort stoppen, Alternativantikoagulation. Antagonist: Protamin

Propofol (ICU-Sedierung) Hypnotikum/Sedativum

DOSIS	0,3-4 mg/kg/h Sedierung ICU
WIRKUNG	Sedierung, Anxiolyse, antiemetisch
NEBENWIRKUNGEN	Propofol-Infusions-Syndrom (>48h, >4mg/kg/h): Azidose, Rhabdomyolyse, Herzversagen!
KONTRAINDIKATIONEN	>48h Dauerinfusion auf ICU vermeiden, Triglyzeride überwachen
PFLEGE & PRAXIS	Triglyzeride kontrollieren, max. 4mg/kg/h, RASS-Score dokumentieren, Analgesie zuerst (PADIS)!

Dexmedetomidin α_2 -Agonist/Sedativum

DOSIS	0,2-1,4 μ g/kg/h i.v.
WIRKUNG	Sedierung ohne Atemdepression, analgetisch, anxiolytisch, sympatholytisch
NEBENWIRKUNGEN	Bradykardie, Hypotonie, Mundtrockenheit
KONTRAINDIKATIONEN	AV-Block Grad II/III, schwere Herzinsuffizienz
PFLEGE & PRAXIS	Patient erweckbar! Weniger Delir als Benzodiazepine. HF und RR überwachen

Notfallmedizin

6 Medikamente

Adrenalin (Reanimation) Katecholamin

DOSIS	1mg i.v./i.o. alle 3-5 Min. (ERC-Leitlinie)
WIRKUNG	Koronarperfusion↑, zerebrale Perfusion↑, Vasokonstriktion
NEBENWIRKUNGEN	Tachykardie, Arrhythmien, Hypertonie nach ROSC
KONTRAINDIKATIONEN	Keine absoluten KI bei Reanimation
PFLEGE & PRAXIS	Während CPR! Nach ROSC: RR, HF, Temperatur überwachen, Zieltemperaturmanagement

Amiodaron Antiarrhythmikum (Klasse III)

DOSIS	300mg i.v. Bolus VF/pVT; 150mg bei Wiederholung
WIRKUNG	Verlängert Repolarisation, antiarrhythmisch bei VF/pVT nach 3. Defibrillation
NEBENWIRKUNGEN	Hypotonie, Bradykardie, Phlebitis, Schilddrüsenprobleme (Langzeit)
KONTRAINDIKATIONEN	Jodallergie (Kurzzeit relativ), Sinusbradykardie
PFLEGE & PRAXIS	Nur über ZVK langfristig, Lichtschutz, Schilddrüsenwerte Langzeit kontrollieren

Atropin Anticholinergikum

DOSIS	0,5-1mg i.v. Bradykardie; max. 3mg
WIRKUNG	Herzfrequenz↑ (vagolytisch), Bronchodilatation, Speichelsekretion↓
NEBENWIRKUNGEN	Tachykardie, Mundtrockenheit, Harnverhalt, Mydriasis, Hyperthermie
KONTRAINDIKATIONEN	Glaukom (relativ), Prostatahyperplasie
PFLEGE & PRAXIS	Bei Asystolie/PEA in der Reanimation nicht mehr empfohlen! EKG-Monitoring, Harnblase kontrollieren

Naloxon Opioid-Antagonist

DOSIS	0,4-2mg i.v./i.m./nasal; titrieren 0,04mg Schritte
WIRKUNG	Kompetitive Verdrängung der Opiode vom Rezeptor → Aufhebung Atemdepression
NEBENWIRKUNGEN	Akutes Entzugssyndrom, Tachykardie, Hypertonie, Lungenödem
KONTRAINDIKATIONEN	Keine absoluten KI bei Atemdepression
PFLEGE & PRAXIS	Kurze HWZ (30-90 Min.)! Opioid wirkt länger → Rebound-Atemdepression! Engmaschiges Monitoring, ggf. wiederholen

Dantrolen Muskelrelaxans (Spezifisch MH)

DOSIS	2,5 mg/kg i.v. Bolus, bis 10mg/kg
WIRKUNG	Hemmung der Kalziumfreisetzung aus sarkoplasmatischem Retikulum → MH-Therapie
NEBENWIRKUNGEN	Muskelschwäche, Phlebitis, Übelkeit
KONTRAINDIKATIONEN	Keine bei MH-Notfall
PFLEGE & PRAXIS	MH-Notfall: sofort Trigger stoppen, 100% O ₂ , Dantrolen, aktive Kühlung. Immer vorrätig im OP!

Glukose 40-50% Antihypoglykämikum

DOSIS	20-40ml G40% i.v. bei Hypoglykämie
WIRKUNG	Sofortiger BZ-Anstieg
NEBENWIRKUNGEN	Venenwandreizung (hyperosmolar!), Hyperglykämie bei Überdosierung
KONTRAINDIKATIONEN	Hyperglykämie
PFLEGE & PRAXIS	Nur über guten Venenzugang! BZ-Kontrolle nach 15 Min., Ursache der Hypoglykämie klären


Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de